



WEEKLY REPORT

友善、公平、藝術、洞察

坐立不安與不滿是進步的第一要件。

-美國發明家 愛迪生

做夢的勇氣與創造360度醫學人生的能力

臨床教育—成人學習

我們每天都在做臨床教學，卻很少停下來想：為什麼這樣教有效？這一季，教學部將用一張地圖，把臨床現場正在發生的教學，整理成一套同仁看得懂的架構。接下來每兩週，我們都會在這張地圖上，標出「現在走到哪裡」。

成人學習：為什麼學員有時候「看起來沒動力」

在醫院的長廊、會議室或是查房途中上，我們其實都曾經看過類似的畫面：資深主治醫師用心良苦地講解病理生理學，邏輯嚴謹、內容完整；而站在一旁的住院醫師卻頻頻低頭滑手機，神情遊離。這樣的場景，常被簡化為一句話——「現在的學員怎麼都沒學習動機？」但如果我們停下來想一秒，問題真的出在沒有學習意願嗎？還是，我們其實用錯了教學的方式。

成人不是不想學，是不想「被當小孩教」

成人的學習，從來不是從零開始。教育學者Knowles把這樣的學習方式稱為「成人學習理論 (Andragogy)」，它不是在告訴我們該怎麼上課，而是提醒我們一件很關鍵、卻常被忽略的事：習慣用教孩子的方式教成人，卻忘了成人早已不是空白的容器。

不論是 PGY、住院醫師，或進修中的主治醫師，這些成人學員都已累積大量的臨床經驗、價值判斷與工作節奏。他們帶著自己的知識架構走進教學現場，需要的不是被「填滿」，而是被協助整合、重組與深化。因此，當教學變成單向灌輸、與實務脫節，成人就會本能地關閉注意力，呈現出「吸收慢」的狀態。那不是怠惰，而是一種防禦。

一季臨床教育理論地圖 (院內版)



有效的成人教學，必須先回答三個問題

在臨床現場，成人學習能否啟動，往往取決於三個極其實際的問題：

1. 為什麼要學？
2. 現在學這個，對我的工作有什麼用？
3. 我在這個學習裡，有沒有選擇權？

舉一個再熟悉不過的臨床教學為例，當主治醫師一開場便說「今天這個胸痛病人，我們要練鑑別診斷與風險分層的思考方式。」學員就會立刻理解：這不是隨機教學，而是一個有目的的訓練，這段時間，值得我專心投入。接著，如果教學者再多做一步，問一句：「你想加強心電圖判讀，還是想練習

如何跟病人談風險？」——這個看似簡單的選擇，其實非常關鍵。因為這份選擇權把學員，從「被教的人」，拉回到「學習的主體」。



教學部 週戰報

經驗不是阻礙，而是成人學習最好的教材

成人學習理論還有一個常被低估的重點：經驗不是教學的干擾，而是教學的起點。當教學者問：「你上次遇到類似病人，最後卡在哪裡？」這一刻，學員不再只是接收資訊的人，而是帶著自己的臨床記憶，重新參與學習。原本零散的經驗，開始被整理、被命名、被重新理解。學員的既有經驗不再是教學的阻礙，反而成為最佳的教材。這也解釋了一個臨床老師們一定很有感的現象：同樣一場教學，資淺醫師覺得抽象吃力，資深醫師卻頻頻點頭。不是因為誰比較聰明，而是後者有足夠的經驗座標，能把新知精準地「放進去」。因為成人的學習，不是線性累加，而是螺旋式深化。

教學的轉折點，往往只差一句話

回到一開始那個會議室的場景，真正的改變，可能不是換教材、換投影片，而是從一個簡單的提問開始：不是「我來教你」，而是「我們一起來想」。成人不需要被「教會」，而需要被「引導著學會怎麼學」。當我們尊重他們的經驗、說清楚學習的目的、給予適度的選擇權，學習就不再是額外的負擔，而會成為一種內在的需求。而臨床教學，也才能從知識的單向輸送，蛻變為專業智慧的雙向共創。

結語

臨床教育不是額外的工作，而是大家每天正在做的專業。我們希望，透過這張臨床教育地圖，陪大家把教學走得更清楚、也更有方向。本週，我們一起在臨床教育地圖的【第一層】向前走了一步，兩週後，邀請您繼續和我們，一起往前。

成人學習理論：速記TIPS

在臨床教學現場，我們常困惑：明明花了時間教，學員卻看起來沒有動力，甚至越教越遠。這時候，我們很容易把原因歸結為「態度」或「世代差異」，比較少停下來想：是不是教學的方式，可能不適合成人學習者？這一張「成人學習理論（Andragogy）」的架構圖，不是要大家記住六大假設或四大原則，而是希望用它，幫自己重新對焦一件事—成人為什麼會願意學。

請不要把這張圖當成教育學知識。它真正的價值，是當我們在查房、門診、交班或教學時，可以在心裡快速對照幾個問題：

- 我有沒有先說清楚「為什麼現在要學這個」？
- 我給的是指令，還是選擇？
- 我有沒有把學員的經驗，當成資源，而不是干擾？

如果你在教學現場，曾經做過其中任何一件事，那你其實早就在做成人學習理論的實踐，只是不知道他有一個正式的理论而已。因為在所有臨床教育的理論中，成人學習不是一個「技巧」，而是一個「前提」。如果學習動機沒有被啟動，後面的經驗反思、能力養成、甚至CBME的建立、EPA的交付，都不會真正發生。所以，這一季的臨床教育專欄，我們選擇從「為什麼他願意學」開始，而不從制度或評量談起。

給臨床老師的3個口訣來即用提醒



① 為什麼：先說「為什麼」，再開始教

在開始講解前，用一句話說清楚目的：「這一段，是為了讓你下次值班更快判斷／少犯一個常見錯誤。」當學員知道「這跟我現在的工作有關」，學習才會啟動。

② 給選擇：提供選項，而不只是給指令

與其說「照我這樣做」，不如試著問：「你想先練哪一個？我再補你沒看到的地方。」選擇權會把學員，從被動聽眾，拉回學習的主體。

③ 拉經驗：把學員的經驗，拉進教學

試著問一句：「你之前有遇過類似的情況嗎？當時卡在哪裡？」成人的經驗不是干擾，而是最好的教材。

永遠記得：成人不是不想學，而是不想被當小孩教。

跨越預後困境：從美國經驗看神經膠質母細胞瘤(GBM)治療的新策略

來自美國布朗大學的陳至正 (Clark C. Chen) 教授日前返台演講，主題聚焦於「神經膠質母細胞瘤(GBM)治療的新策略」。這位擁有史丹佛、哈佛及哥倫比亞大學學術背景的臺灣子弟，現任布朗大學腦瘤計畫主任，他帶回了在美國執業十餘年來，邁向精準與微創神經外科的第一線經驗。

手術進步的三大支柱

陳教授指出手術的進步需仰賴三大要素的完美交集：對解剖與生理學的深厚理解、醫師累積的臨床技術，以及科技的有效運用。他以航行作比喻：「解剖生理學是航海圖，手術技術是醫師掌舵經驗，創新科技則是更先進的雷達與引擎。唯有三者結合，才能在GBM治療的險峻海域中，為病人找到生機」



三大創新技術改寫禁區

首先是「腦幹立體定位切片」技術。過去腦幹被視為手術禁區，如今透過精準定位，醫師得以安全取得檢體，為標靶治療奠定基礎——「有了檢體，才能做好精準治療」，陳教授強調。

其次是「LITT雷射消融手術」，這項技術讓深部腫瘤治療不再需要開顱，大幅降低手術風險與復原時間。

第三項則是針對表淺腫瘤的「鑰匙孔內視鏡手術」。陳教授引述最新研究指出，顱骨在腦部免疫系統中扮演關鍵角色，切除範圍越小，病人預後越好——這個發現改變傳統手術思維。



搭建臺美醫學合作橋樑

此次演講不僅是技術分享，更承載著深遠意義。陳教授希望透過美國臨床研究經驗，提升臺灣神經腫瘤治療的研究能量，並建立臺美兩地在資源整合與臨床研究上的長期夥伴關係。

對臺灣腦瘤病人而言，這場跨海而來的知識交流，帶來的不只是醫療技術的更新，還包含了能突破治療困境的新曙光。



在日常中重塑：教師培育 這些年，我們一起走過的路

教學部 汶秀

這是一位教學行政人員眼中的教師培育重塑之路

回想這些年，教師培育成為我工作中最常被提起、也最常反覆思考的一件事。不是因為它突然變得重要，而是在一次次整理資料、協調會議、回應現場需求的過程中，慢慢發現，原來我每天在做的這些行政工作，其實正默默影響著教學能不能走得長久。對我來說，教師培育原本是分散存在於不同工作項目中；直到開始重新整理制度與流程，才逐漸看見，這些看似各自獨立的事情，其實指向同一個方向。

一開始，依著既有流程處理事情，彙整資料、安排會議、回應詢問，覺得這些都是行政工作的一部分。但隨著醫學教育委員會開始更有系統地討論教師培育方向，我才意識到，這些零碎的工作背後，其實牽動著一個更大的問題：**我們是否真的為教學建立了一個可以長久依靠的支持架構**。也正是在這樣的思考中，教師培育不再只是工作清單上的一項任務，而成為需要被好好整理的重要基礎。

接著，教學部承接了這些方向，嘗試將共識轉化為較為清楚、可運作的制度。從行政角度來看，**這是一段反覆修正的過程**。有些流程在紙上看起來完整，實際卻不一定貼近臨床；也有些調整，是在一次次與委員、同仁討論後才逐步成形。慢慢地，我們更確定，**組織重塑的目的不是增加規範，而是讓教學不再各自承擔**。



在調整過程中，**教師培育中心也逐漸回到它的核心角色**。比起辦了多少活動，更重要的是，能否**讓教師感受到被支持**。無論是剛開始接觸教學的同仁，或是已有多多年經驗的老師，培育制度的存在，都是希望在需要時，有人能接得住、給得上協助，而不是只留下形式上的安排。

這一年整理制度的過程，也讓我更深刻體會到，教師培育與醫療品質之間，其實距離並不遠。當教師在教學中有餘裕提醒風險、示範安全流程、引導學員思考判斷後果，病人往往是最直接的受益者。教學不是離臨床很遠的事，而是每天在現場累積的選擇與態度。

展望未來，教師培育仍會持續調整。身為行政人員，我能做的，是在後面把制度整理好，讓願意教的人走得更穩，也讓學員在安全中學習，讓醫療品質與病人安全在日常中慢慢累積。